QCM de révision

63 questions · Corrigés regroupés à la fin

Définitions et raisonnement

Q01 **Que désigne une étiologie ? (1 bonne réponse)** Facile

- ☐ A. La sensibilité aux antibiotiques.
- ☐ B. Un prélèvement de selles.
- ☐ C. La cause d'une maladie.
- ☐ D. La quantité de bactéries ingérées.
- ☐ E. Le temps avant les symptômes.

Q02 **Que désigne l'incubation d'une infection ? (1 bonne réponse)** Facile

- ☐ A. La durée de la diarrhée uniquement.
- ☐ B. La quantité de germes ingérés.
- ☐ C. L'intervalle contamination–premiers symptômes.
- ☐ D. La durée de conservation des selles.
- ☐ E. La période de culture d'un prélèvement uniquement.

Q03 **Que désigne l'inoculum ? (1 bonne réponse)** Facile

- ☐ A. Une quantité d'agents infectieux.
- ☐ B. Le nombre de récidives.
- ☐ C. Une durée avant les symptômes.
- ☐ D. Le nombre de selles par jour.
- ☐ E. Le type de milieu de culture.

Q04 **Quelles données décrivent directement une diarrhée ? (3 bonnes réponses)** Moyen

- ☐ A. La consistance des selles.
- ☐ B. La fréquence des selles.
- ☐ C. Le sérotype isolé décrit directement la consistance des selles.
- ☐ D. La sensibilité antibiotique décrit directement la fréquence des selles.
- ☐ E. L'évolution dans le temps.

Q05 Facile

Quelle différence distingue fréquence d'une maladie et gravité ? (1 bonne réponse)

- ☐ A. Le nombre de cas et le retentissement sont deux dimensions distinctes.
- ☐ B. Un nombre faible de cas exclut une complication individuelle.
- ☐ C. La gravité est définie par le nom du prélèvement.
- ☐ D. Une infection virale ne peut pas entraîner de pertes hydriques importantes.
- ☐ E. Un agent fréquent provoque nécessairement les complications les plus graves.

Virus et transmission

Q06 Facile

Que signifie une transmission féco-orale ? (1 bonne réponse)

- ☐ A. Une ingestion d'un aliment forcément stérile.
- ☐ B. Une transmission ne pouvant impliquer les mains.
- ☐ C. Une transmission exclusivement par piqûre.
- ☐ D. Un passage depuis les selles jusqu'à une ingestion.
- ☐ E. Un passage obligatoire par le sang.

Q07 Moyen

Quels intermédiaires peuvent participer à une transmission féco-orale indirecte ? (3 bonnes réponses)

- ☐ A. Une surface contaminée.
- ☐ B. Le sang circulant est un intermédiaire obligatoire de toute transmission féco-orale indirecte.
- ☐ C. Un aliment contaminé.
- ☐ D. Un contact direct entre personnes sans intermédiaire définit la transmission indirecte.
- ☐ E. Une eau contaminée.

Q08 Facile

Dans une transmission croisée, que se passe-t-il ? (1 bonne réponse)

- ☐ A. Un agent se diffuse uniquement entre deux organes d'une même personne.
- ☐ B. Une bactérie acquiert un nouveau facteur de virulence.
- ☐ C. Le germe passe obligatoirement de l'animal à l'homme.
- ☐ D. La contamination se fait nécessairement par le même aliment.
- ☐ E. L'agent peut passer d'une personne à une autre.

Q09 **Pourquoi un téléphone manipulé auprès du patient peut-il intervenir dans la transmission ? (1 bonne réponse)** Facile

- [ ] A. Parce que toute transmission par téléphone est obligatoirement sanguine.
- [ ] B. Parce que toucher l'écran remplace le lavage des mains.
- [ ] C. Parce qu'un objet visiblement propre ne peut pas porter d'agent.
- [ ] D. Il peut servir de surface intermédiaire contaminée.
- [ ] E. Parce que seule une ingestion du téléphone permet la contamination.

Q10 **Comment une eau souillée peut-elle participer à une infection digestive ? (2 bonnes réponses)** Moyen

- [ ] A. Uniquement si elle provoque immédiatement des symptômes.
- [ ] B. Uniquement après avoir été bue par plusieurs personnes.
- [ ] C. Par la contamination d'aliments.
- [ ] D. Uniquement par contact avec une peau intacte, sans ingestion ni aliment.
- [ ] E. Par sa consommation.

Q11 **Comment un manipulateur infecté peut-il contaminer un aliment ? (1 bonne réponse)** Facile

- [ ] A. Lors de la manipulation de l'aliment.
- [ ] B. Uniquement par un contact avec le sang du consommateur.
- [ ] C. Uniquement après l'ingestion de l'aliment par le consommateur.
- [ ] D. En contaminant une surface, sans possibilité ultérieure de transfert à l'aliment.
- [ ] E. La contamination alimentaire exclut le rôle des mains.

Q12 **Quelle idée résume le péril fécal ? (1 bonne réponse)** Facile

- [ ] A. Le risque associé exclusivement à des bactéries présentes dans le sang.
- [ ] B. Le risque lié à la contamination par des matières fécales.
- [ ] C. Une contamination limitée aux aliments sans rôle possible de l'eau.
- [ ] D. Une transmission seulement entre animaux.
- [ ] E. Une complication rénale propre à toutes les diarrhées.

Q13 **Quel contexte clinique associe-t-on au rotavirus ? (1 bonne réponse)** Facile

- [ ] A. Salmonella Typhi et bactériémie sont les deux noms du rotavirus.
- [ ] B. Le rotavirus désigne le groupe des E. coli urinaires.
- [ ] C. Le poulet mal cuit est le repère principal demandé pour identifier le rotavirus.
- [ ] D. Le rotavirus appartient aux salmonelles mineures.
- [ ] E. Jeune enfant et épidémies de saison froide.

Q14 Moyen

Dans quels contextes rencontre-t-on les gastro-entérites à norovirus ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. Le norovirus est défini par un tableau exclusivement urinaire.
- [ ] B. Des épisodes collectifs.
- [ ] C. Le norovirus est une bactérie de la typhoïde.
- [ ] D. Des contaminations alimentaires ou hydriques.
- [ ] E. L'infection à norovirus ne peut concerner qu'une personne isolée.

Q15 Facile

Comment comparer la saisonnalité des adénovirus entériques à celle du rotavirus ? (1 bonne réponse)

- [ ] A. Ils ne peuvent survenir que pendant la saison des barbecues.
- [ ] B. Ils sont obligatoirement absents en dehors de l'hiver.
- [ ] C. Leur saisonnalité est identique par définition à celle décrite pour le rotavirus.
- [ ] D. La saison suffit à distinguer avec certitude un adénovirus d'un norovirus.
- [ ] E. Un caractère saisonnier moins marqué.

Q16 Moyen

Quels publics peuvent être concernés par les gastro-entérites à astrovirus ? (3 bonnes réponses)

- [ ] A. Les enfants.
- [ ] B. Seulement les personnes revenant d'un même repas collectif.
- [ ] C. Uniquement les personnes atteintes d'une typhoïde.
- [ ] D. Les personnes immunodéprimées.
- [ ] E. Les personnes âgées.

Q17 Facile

Pourquoi les vomissements peuvent-ils intervenir dans une chaîne de transmission digestive ? (1 bonne réponse)

- [ ] A. Ils prouvent une transmission sanguine.
- [ ] B. Ils empêchent toute contamination de l'environnement.
- [ ] C. Ils identifient à eux seuls le virus responsable.
- [ ] D. Ils excluent des pertes hydriques associées.
- [ ] E. Ils peuvent s'accompagner d'une dispersion contaminante.

Pertes hydriques et réhydratation

Q18 **Quel problème la réhydratation vise-t-elle à corriger lors d'une diarrhée ? (1 bonne réponse)** Facile

- [ ] A. La distinction entre salmonelles majeures et mineures.
- [ ] B. Les pertes hydriques et électrolytiques.
- [ ] C. L'identification d'un sérotype.
- [ ] D. La sélection de colonies en culture.
- [ ] E. La sensibilité de la souche aux antibiotiques.

Q19 **Quel couplage est utilisé par les solutés de réhydratation orale ? (1 bonne réponse)** Facile

- [ ] A. L'absorption couplée sodium–glucose.
- [ ] B. L'absorption couplée du sang et du mucus.
- [ ] C. La fixation d'une bactérie aux macrophages.
- [ ] D. La recherche simultanée de plusieurs gènes.
- [ ] E. L'invasion de la muqueuse par Shigella.

Q20 **Pourquoi ne faut-il pas confondre antidiarrhéique et réhydratation ? (1 bonne réponse)** Facile

- [ ] A. Les deux termes désignent une identification de l'agent.
- [ ] B. La modification de la fréquence des selles prouve que les pertes sont déjà corrigées.
- [ ] C. Une diarrhée virale ne s'accompagne jamais de pertes d'eau.
- [ ] D. Un résultat de coproculture mesure directement toute la réhydratation reçue.
- [ ] E. Agir sur les selles ne signifie pas avoir corrigé les pertes.

Salmonelles et typhoïde

Q21 **Quels groupes faut-il distinguer parmi les salmonelles ? (2 bonnes réponses)** Moyen

- [ ] A. Les salmonelles mineures ou non typhiques.
- [ ] B. Rotavirus et norovirus sont deux groupes de salmonelles.
- [ ] C. Typhi et Paratyphi parmi les salmonelles majeures.
- [ ] D. EIEC et UPEC sont les deux salmonelles majeures.
- [ ] E. C. difficile est classé parmi les salmonelles mineures.

Q22 **Quel est le réservoir des salmonelles typhiques ? (1 bonne réponse)** Moyen

- [ ] A. Les volailles exclusivement.
- [ ] B. L'ensemble des animaux, sans réservoir humain.
- [ ] C. Uniquement les eaux naturelles, sans personne porteuse.
- [ ] D. Les animaux de compagnie exclusivement.
- [ ] E. L'être humain.

Q23 **Pourquoi la typhoïde peut-elle donner des manifestations générales ? (1 bonne réponse)** Moyen

- [ ] A. Parce que l'infection demeure obligatoirement à la surface de l'aliment.
- [ ] B. Une dissémination peut suivre le franchissement intestinal.
- [ ] C. Parce que l'absence de diarrhée exclut toute atteinte systémique.
- [ ] D. Parce que la bactérie ne peut pas franchir la barrière intestinale.
- [ ] E. Parce que tous les symptômes sont dus au seul nombre de selles.

Q24 **Quelle place les macrophages ont-ils dans la physiopathologie de la typhoïde ? (1 bonne réponse)** Moyen

- [ ] A. Ils ne sont présents que sur les surfaces alimentaires.
- [ ] B. Ils désignent un groupe de salmonelles mineures.
- [ ] C. Ils remplacent le sérotypage pour identifier Typhi.
- [ ] D. Ils sont le nom d'un prélèvement de selles.
- [ ] E. Ils peuvent héberger la bactérie dans le modèle décrit.

Q25 **Pourquoi une constipation n'écarte-t-elle pas un tableau de typhoïde ? (1 bonne réponse)** Moyen

- [ ] A. Elle est citée parmi les présentations possibles.
- [ ] B. Elle identifie à elle seule un norovirus.
- [ ] C. Elle signifie que l'atteinte est nécessairement limitée à un repas contaminé sans infection.
- [ ] D. Elle garantit l'absence de bactériémie.
- [ ] E. Elle permet de distinguer Typhi et Paratyphi sans analyse.

Q26 **Que signifie un pouls dissocié dans un tableau de typhoïde ? (1 bonne réponse)** Moyen

- [ ] A. Un rapport constant entre le nombre de selles et le pouls.
- [ ] B. Un décalage entre la fièvre et la réponse habituelle du pouls.
- [ ] C. Une accélération du pouls proportionnelle à chaque selle.
- [ ] D. Une absence obligatoire de fièvre.
- [ ] E. Une absence de tout signe général.

Q27 **Quel prélèvement recherche une bactériémie dans la typhoïde ? (1 bonne réponse)** Moyen

- ☐ A. Une coproculture définit à elle seule le prélèvement sanguin.
- ☐ B. Un prélèvement de sang pour hémocultures.
- ☐ C. Un prélèvement de surfaces de cuisine remplace le sang du patient.
- ☐ D. L'observation du pouls suffit comme prélèvement microbiologique.
- ☐ E. Un questionnaire alimentaire constitue une hémoculture.

Q28 **Quels éléments peuvent caractériser une salmonellose non typhique ? (2 bonnes réponses)** Moyen

- ☐ A. Un réservoir uniquement humain, identique à celui des salmonelles typhiques.
- ☐ B. Une diarrhée fébrile avec douleurs ou vomissements.
- ☐ C. Une absence obligatoire de signes digestifs.
- ☐ D. Une contamination alimentaire.
- ☐ E. Une infection exclusivement urinaire.

Q29 **Quelles complications intestinales peuvent survenir dans la typhoïde ? (2 bonnes réponses)** Moyen

- ☐ A. Des hémorragies intestinales.
- ☐ B. Des perforations intestinales.
- ☐ C. Une simple identification de sérotype est une lésion intestinale.
- ☐ D. Une augmentation de la fréquence des selles constitue par définition une perforation.
- ☐ E. Une colonisation asymptomatique constitue à elle seule une hémorragie.

TIAC et prévention générale

Q30 **Que signifie le sigle TIAC ? (1 bonne réponse)** Facile

- ☐ A. Toxi-infection alimentaire communautaire.
- ☐ B. Toxi-infection aiguë chronique.
- ☐ C. Toxi-infection alimentaire collective.
- ☐ D. Transmission interhumaine alimentaire croisée.
- ☐ E. Trouble intestinal alimentaire chronique.

Q31 Facile

Quel objectif guide l'enquête devant plusieurs malades après un repas commun ? (1 bonne réponse)

- ☐ A. Conclure à une même espèce uniquement sur le partage du repas.
- ☐ B. Se limiter au seul traitement de chaque cas, sans chercher l'exposition.
- ☐ C. Écarter l'eau parce que l'épisode paraît alimentaire.
- ☐ D. Rechercher seulement le nombre de colonies, sans retracer les repas.
- ☐ E. Identifier le point commun aux personnes atteintes.

Q32 Moyen

Quels éléments participent à la prévention de la contamination alimentaire ? (3 bonnes réponses)

- ☐ A. Remplacer le respect du froid par l'attente d'un résultat PCR.
- ☐ B. L'hygiène des mains.
- ☐ C. Le respect de la chaîne du froid.
- ☐ D. La maîtrise de l'eau utilisée.
- ☐ E. Éliminer les excrétas au même endroit que la préparation des aliments.

Q33 Facile

Pourquoi l'élimination d'excrétas dans un évier pose-t-elle problème ? (1 bonne réponse)

- ☐ A. Parce que cela équivaut à effectuer une coproculture.
- ☐ B. Parce que cela réalise la désinfection du point d'eau.
- ☐ C. Parce que le risque ne concerne que la personne qui utilise l'évier.
- ☐ D. Elle peut contaminer l'environnement de soin.
- ☐ E. Parce que tout point d'eau remplace le circuit des excrétas.

Shigella et syndrome dysentérique

Q34 Facile

Quel mécanisme intestinal est associé à Shigella ? (1 bonne réponse)

- ☐ A. Une atteinte exclusivement urinaire.
- ☐ B. Une absence obligatoire de toute lésion épithéliale.
- ☐ C. Une contamination alimentaire sans contact avec la muqueuse après ingestion.
- ☐ D. Une invasion de la muqueuse avec inflammation.
- ☐ E. Un simple changement de consistance sans réaction inflammatoire possible.

Q35 **Que décrit le terme muco-sanglant ? (1 bonne réponse)** Facile

- [ ] A. Des selles uniquement aqueuses, sans mucus ni sang.
- [ ] B. Du mucus et du sang.
- [ ] C. Du mucus sans sang.
- [ ] D. Du sang sans mucus.
- [ ] E. Une présence exclusive de cellules bactériennes en culture.

Q36 **Quels éléments appartiennent au syndrome dysentérique ? (2 bonnes réponses)** Moyen

- [ ] A. Une absence obligatoire de douleurs abdominales.
- [ ] B. Une absence de lésion muqueuse par définition.
- [ ] C. Des selles glairo-sanglantes ou purulentes.
- [ ] D. Des douleurs et des besoins douloureux d'évacuation.
- [ ] E. Un résultat positif de sérotypage considéré comme un symptôme.

Q37 **Quel rôle les polynucléaires neutrophiles jouent-ils lors d'une atteinte intestinale inflammatoire ? (1 bonne réponse)** Facile

- [ ] A. Ils correspondent à l'agent viral de la diarrhée.
- [ ] B. Ils sont le réservoir alimentaire de Salmonella.
- [ ] C. Leur présence identifie à elle seule l'espèce bactérienne.
- [ ] D. Une participation à la réponse inflammatoire.
- [ ] E. Ils indiquent directement la sensibilité aux antibiotiques.

Q38 **Quelle voie de contamination peut transmettre Shigella ? (2 bonnes réponses)** Moyen

- [ ] A. Une contamination exclusivement par prélèvement sanguin.
- [ ] B. L'ingestion d'eau souillée.
- [ ] C. Une transmission sans ingestion possible d'un agent digestif.
- [ ] D. Une acquisition obligatoire après un antibiogramme.
- [ ] E. L'ingestion d'aliments souillés.

Yersinioses digestives

Q39 **Quelles espèces de Yersinia sont associées aux diarrhées ? (2 bonnes réponses)** Moyen

- [ ] A. Yersinia pestis comme seul agent des yersinioses digestives.
- [ ] B. Yersinia pseudotuberculosis.
- [ ] C. Yersinia enterocolitica.
- [ ] D. Salmonella Typhi.
- [ ] E. Norovirus.

Q40 **Quelle forme digestive de yersiniose peut survenir chez le petit enfant ? (1 bonne réponse)** Facile

- [ ] A. Une infection urinaire définissant UPEC.
- [ ] B. Une typhoïde systémique à Salmonella Typhi par définition.
- [ ] C. Une forme entéritique.
- [ ] D. Un portage totalement asymptomatique définissant la forme entéritique.
- [ ] E. Une forme sans aucune manifestation intestinale.

Q41 **Quels mécanismes peuvent expliquer une douleur de la fosse iliaque droite dans une yersiniose ? (1 bonne réponse)** Facile

- [ ] A. Une infection exclusivement urinaire, sans atteinte digestive.
- [ ] B. Une diarrhée virale identifiée par la seule localisation de la douleur.
- [ ] C. Une disparition de l'inflammation des ganglions.
- [ ] D. Une adénite et une inflammation de l'iléon terminal.
- [ ] E. Une altération de la sensibilité antibiotique comme unique cause de la douleur.

Escherichia coli : flore et invasion

Q42 **Pourquoi le seul nom Escherichia coli ne résume-t-il pas le pouvoir pathogène ? (2 bonnes réponses)** Moyen

- [ ] A. Toutes les souches ont obligatoirement un tropisme exclusivement urinaire.
- [ ] B. E. coli peut appartenir à la flore digestive habituelle.
- [ ] C. E. coli est un virus digestif.
- [ ] D. La présence digestive d'E. coli signifie toujours le même syndrome.
- [ ] E. Certaines souches ont des facteurs de virulence particuliers.

Q43 **À quel mécanisme le groupe EIEC est-il associé ? (1 bonne réponse)** Facile

- [ ] A. Un mécanisme entéro-invasif.
- [ ] B. Un mécanisme exclusivement urinaire.
- [ ] C. Une absence d'invasion définissant EIEC.
- [ ] D. Le mécanisme systémique propre aux salmonelles typhiques.
- [ ] E. Un groupe de virus digestifs saisonniers.

Q44 **Quel tableau digestif peut être associé aux Escherichia coli entéro-invasifs ? (1 bonne réponse)** Facile

- ☐ A. Un tableau dysentérique avec selles muco-sanglantes.
- ☐ B. Une infection exclusivement urinaire définissant EIEC.
- ☐ C. Une absence obligatoire d'atteinte intestinale.
- ☐ D. Une typhoïde due par définition à Salmonella Typhi.
- ☐ E. Un portage asymptomatique constituant à lui seul le syndrome dysentérique.

Q45 **Que désigne le groupe des Escherichia coli uropathogènes ? (1 bonne réponse)** Facile

- ☐ A. Des E. coli associés à des infections urinaires.
- ☐ B. Un groupe de salmonelles typhiques.
- ☐ C. Un groupe d'E. coli défini uniquement par une invasion intestinale.
- ☐ D. Un virus à transmission alimentaire.
- ☐ E. Un synonyme de Shigella.

Campylobacter et alimentation

Q46 **Quel réservoir est particulièrement associé à Campylobacter ? (1 bonne réponse)** Facile

- ☐ A. Le tube digestif des animaux, notamment des volailles.
- ☐ B. Un réservoir strictement humain, comme pour les salmonelles typhiques.
- ☐ C. Uniquement la flore humaine, sans lien avec les animaux.
- ☐ D. Les virus hivernaux comme réservoir bactérien.
- ☐ E. Uniquement l'eau de boisson, à l'exclusion de tout animal.

Q47 **Comment une carcasse de volaille peut-elle être contaminée par son contenu digestif ? (1 bonne réponse)** Facile

- ☐ A. Par la seule apparition de symptômes chez le consommateur.
- ☐ B. Uniquement si le consommateur a déjà une bactériémie.
- ☐ C. Par une cuisson insuffisante qui constitue à elle seule le réservoir animal.
- ☐ D. Uniquement après identification d'un sérotype chez le consommateur.
- ☐ E. Par un contact avec le contenu digestif de l'animal.

Q48 **Quelles expositions peuvent transmettre Campylobacter ? (3 bonnes réponses)** Moyen

- [ ] A. Le seul partage d'un compte rendu d'analyse.
- [ ] B. Une eau souillée.
- [ ] C. Une présence imposée de Salmonella Typhi avant toute ingestion.
- [ ] D. Une volaille insuffisamment cuite.
- [ ] E. Du lait non pasteurisé contaminé.

Q49 **Que signifie une zoonose ? (1 bonne réponse)** Facile

- [ ] A. Une quantité de germes.
- [ ] B. Une période entre contamination et symptômes.
- [ ] C. Un synonyme de culture de selles.
- [ ] D. Un test de sensibilité d'un antibiotique.
- [ ] E. Une infection transmise depuis l'animal.

Q50 **Pourquoi une volaille insuffisamment cuite au barbecue peut-elle exposer à Campylobacter ? (1 bonne réponse)** Facile

- [ ] A. Parce que la saison identifie avec certitude le germe chez chaque personne.
- [ ] B. Parce que toute viande grillée constitue un milieu sélectif de laboratoire.
- [ ] C. Parce qu'un repas estival implique obligatoirement Salmonella Typhi.
- [ ] D. Pour illustrer le risque d'une volaille mal cuite.
- [ ] E. Parce que la cuisson est sans rapport avec le risque présenté.

Q51 **Quels signes peuvent accompagner une entérite à Campylobacter ? (2 bonnes réponses)** Moyen

- [ ] A. Un résultat de sérotypage considéré comme une manifestation clinique.
- [ ] B. Une diarrhée.
- [ ] C. Une fièvre et des vomissements.
- [ ] D. Une absence obligatoire de tout signe digestif.
- [ ] E. Un antibiogramme positif constituant la définition de la fièvre.

Nomenclature et portage

Q52 **Quelle paire de noms désigne le même agent bactérien ? (1 bonne réponse)** Facile

- ☐ A. Clostridioides difficile et Norovirus.
- ☐ B. Clostridioides difficile et Yersinia pestis.
- ☐ C. Clostridioides difficile et Clostridium difficile.
- ☐ D. Clostridioides difficile et Salmonella Typhi.
- ☐ E. Clostridioides difficile et UPEC.

Q53 **Que signifie un portage asymptomatique ? (1 bonne réponse)** Facile

- ☐ A. Un antibiogramme systématiquement négatif.
- ☐ B. Une diarrhée obligatoire à chaque présence.
- ☐ C. Un synonyme de perforation intestinale.
- ☐ D. Une absence obligatoire de tout micro-organisme.
- ☐ E. Une présence sans symptômes attribuables.

Prélèvements et laboratoire

Q54 **Quel échantillon est au centre de l'exploration microbiologique d'une diarrhée ? (1 bonne réponse)** Moyen

- ☐ A. Un échantillon de surface de cuisine remplace toujours les selles du patient.
- ☐ B. Le seul questionnaire alimentaire.
- ☐ C. La mesure du pouls.
- ☐ D. Des selles.
- ☐ E. Un résultat d'antibiogramme ancien.

Q55 **Que désigne une coproculture ? (1 bonne réponse)** Moyen

- ☐ A. Une culture de sang.
- ☐ B. Une mesure de la fréquence des selles.
- ☐ C. Une culture de selles.
- ☐ D. Une caractérisation antigénique de Salmonella.
- ☐ E. Une recherche génétique de plusieurs cibles sans culture.

Q56 **Pourquoi rechercher des agents spécifiques au sein des selles ? (1 bonne réponse)** Moyen

- ☐ A. Les selles ne contiennent par définition qu'une seule espèce.
- ☐ B. La description clinique suffit à nommer toutes les colonies.
- ☐ C. La flore digestive est abondante et diversifiée.
- ☐ D. Tous les micro-organismes des selles sont interchangeables.
- ☐ E. La présence d'une flore habituelle empêche toute recherche ciblée.

Q57 **Que recherche une analyse par PCR ? (1 bonne réponse)** Moyen

- ☐ A. Uniquement la fréquence des selles du patient.
- ☐ B. L'aspect macroscopique des selles seulement.
- ☐ C. Le profil de croissance sur chaque milieu sélectif uniquement.
- ☐ D. La sensibilité complète à tous les antibiotiques, par définition.
- ☐ E. Une cible génétique.

Q58 **Que signifie multiplex pour une analyse PCR ? (1 bonne réponse)** Moyen

- ☐ A. Une durée d'analyse obligatoirement fixée à plusieurs jours.
- ☐ B. La recherche simultanée de plusieurs cibles.
- ☐ C. La présence obligatoire de plusieurs agents chez chaque patient.
- ☐ D. Une seule culture sélective destinée à une unique cible.
- ☐ E. Une identification fondée uniquement sur l'aspect des selles.

Q59 **À quoi sert un milieu sélectif en coproculture ? (1 bonne réponse)** Moyen

- ☐ A. À réhydrater le patient.
- ☐ B. À décrire la fréquence des selles.
- ☐ C. À remplacer toute identification après culture.
- ☐ D. À aider à isoler les agents recherchés.
- ☐ E. À mesurer directement les pertes d'eau du patient.

Q60 **À quoi sert le MALDI-TOF pour des colonies bactériennes ? (1 bonne réponse)** Moyen

- ☐ A. La réhydratation orale.
- ☐ B. L'enquête sur un repas commun.
- ☐ C. La mesure de la fréquence des selles.
- ☐ D. L'identification de colonies.
- ☐ E. La préparation d'un prélèvement sanguin au lit du patient.

Q61 **À quoi sert le sérotypage des salmonelles ? (1 bonne réponse)** Moyen

- ☐ A. Pour mesurer le volume d'eau perdu.
- ☐ B. Pour préciser les salmonelles majeures ou mineures.
- ☐ C. Pour modifier le groupe de la souche.
- ☐ D. Pour compter les épisodes de diarrhée.
- ☐ E. Pour étudier directement la sensibilité aux antibiotiques.

Q62 **Quelle information apporte un antibiogramme ? (1 bonne réponse)** Moyen

- ☐ A. La certitude que toute diarrhée impose un antibiotique.
- ☐ B. Le volume exact de la diarrhée.
- ☐ C. Le nombre de personnes ayant partagé un repas.
- ☐ D. Une étude de sensibilité aux antibiotiques.
- ☐ E. La consistance des selles sans observation.

Q63 **Pourquoi une première détection ne fournit-elle pas toujours toutes les informations biologiques ? (1 bonne réponse)** Moyen

- ☐ A. Toute première détection contient obligatoirement un antibiogramme complet.
- ☐ B. La seule fréquence des selles identifie toutes les bactéries.
- ☐ C. Les étapes n'apportent pas la même information.
- ☐ D. Une identification de sérotype donne automatiquement le volume des pertes.
- ☐ E. Culture et PCR sont des noms strictement équivalents.

Corrigés argumentés

Définitions et raisonnement

Q01 — Réponses : C. A — Faux. Elle est étudiée par l'antibiogramme. B — Faux. Il s'agit d'un échantillon biologique. C — Vrai. Elle répond à la question de l'origine du trouble. D — Faux. Cette quantité correspond à l'inoculum. E — Faux. Cet intervalle correspond à l'incubation.

Q02 — Réponses : C. A — Faux. Elle est postérieure à l'apparition des symptômes. B — Faux. Il s'agit de l'inoculum. C — Vrai. Il précède l'expression clinique. D — Faux. C'est un délai préanalytique, pas l'incubation de la maladie. E — Faux. Le mot est ici appliqué à l'infection du patient, pas au laboratoire.

Q03 — Réponses : A. A — Vrai. C'est une notion de dose d'exposition. B — Faux. Il décrit les épisodes successifs. C — Faux. C'est l'incubation. D — Faux. C'est un élément de description clinique. E — Faux. Le milieu est un outil du laboratoire.

Q04 — Réponses : A, B, E. A — Vrai. Elle décrit notamment leur caractère liquide. B — Vrai. Elle décrit le rythme des émissions. C — Faux. Le sérotype caractérise la souche, pas la consistance. D — Faux. La fréquence nécessite une observation clinique distincte. E — Vrai. Elle renseigne sur le début et la persistance.

Q05 — Réponses : A. A — Vrai. La fréquence ne mesure pas les complications ou les pertes hydriques. B — Faux. La rareté ne préjuge pas du retentissement chez une personne. C — Faux. Le prélèvement aide au diagnostic, sans définir à lui seul la gravité. D — Faux. La déshydratation peut être importante lors d'une gastro-entérite virale. E — Faux. La fréquence ne permet pas cette déduction.

Virus et transmission

Q06 — Réponses : D. A — Faux. Le risque décrit est lié à sa contamination. B — Faux. Les mains constituent au contraire un intermédiaire important. C — Faux. Ce n'est pas le trajet féco-oral. D — Vrai. Le trajet relie l'excrétion à l'entrée digestive. E — Faux. La voie décrite est digestive, sans étape sanguine obligatoire.

Q07 — Réponses : A, C, E. A — Vrai. Elle peut contaminer des mains puis une autre personne. B — Faux. Les trajets décrits passent par eau, aliments ou surfaces sans étape sanguine obligatoire. C — Vrai. Son ingestion peut exposer à l'agent. D — Faux. Cette proposition confond direct et indirect. E — Vrai. Elle peut être ingérée ou contaminer un aliment.

Corrigés argumentés

Q08 — Réponses : E. A — Faux. La transmission croisée concerne le passage entre personnes. B — Faux. Acquisition de virulence et transmission entre personnes sont deux notions différentes. C — Faux. Ce trajet caractérise une zoonose, pas toute transmission croisée. D — Faux. Un intermédiaire alimentaire est possible mais n'est pas obligatoire. E — Vrai. La transmission croisée relie plusieurs personnes.

Q09 — Réponses : D. A — Faux. Le téléphone est une surface touchée par les mains. B — Faux. La manipulation ne constitue pas une hygiène des mains. C — Faux. L'absence de souillure visible ne suffit pas à écarter le transfert décrit. D — Vrai. Le mécanisme est celui d'un objet touché par les mains. E — Faux. Des transferts successifs entre surface et mains suffisent à expliquer son rôle.

Q10 — Réponses : C, E. A — Faux. Le trajet de transmission ne dépend pas d'une apparition immédiate des symptômes. B — Faux. Une exposition individuelle reste possible. C — Vrai. L'eau peut intervenir avant l'ingestion de l'aliment. D — Faux. Ce n'est pas le trajet digestif exposé dans cette question. E — Vrai. L'ingestion peut exposer à un agent présent dans l'eau.

Q11 — Réponses : A. A — Vrai. La préparation d'un aliment peut y transférer un agent infectieux. B — Faux. Le trajet décrit concerne la préparation et l'ingestion d'un aliment. C — Faux. La contamination de préparation précède cette ingestion. D — Faux. Les surfaces peuvent intervenir comme intermédiaires. E — Faux. Les mains peuvent justement transférer l'agent.

Q12 — Réponses : B. A — Faux. Le péril fécal renvoie aux matières fécales et aux expositions digestives. B — Vrai. Il relie excrétas et exposition digestive. C — Faux. L'eau fait partie des intermédiaires cités. D — Faux. La transmission féco-orale concerne aussi les contaminations humaines. E — Faux. Une complication à distance ne définit pas le péril fécal.

Q13 — Réponses : E. A — Faux. Le virus et la salmonelle sont des agents distincts. B — Faux. UPEC est le groupe d'E. coli associé aux infections urinaires. C — Faux. La volaille est un repère de contamination par Campylobacter. D — Faux. Le rotavirus est un virus et non une salmonelle. E — Vrai. Ce sont les deux repères présentés.

Q14 — Réponses : B, D. A — Faux. Les contextes discutés sont des gastro-entérites. B — Vrai. L'agent est décrit dans des situations de transmission groupée. C — Faux. La typhoïde est rattachée à Salmonella Typhi, distincte de ce virus. D — Vrai. Une origine alimentaire ou hydrique peut expliquer une gastro-entérite à norovirus. E — Faux. Le norovirus peut être impliqué dans des épisodes collectifs.

Corrigés argumentés

Q15 — Réponses : E. A — Faux. Les gastro-entérites à adénovirus entériques ne sont pas limitées à l'été. B — Faux. Le repère présenté est justement un caractère saisonnier moins marqué. C — Faux. Les adénovirus entériques ont une saisonnalité moins marquée que le rotavirus. D — Faux. Un contexte saisonnier ne fournit pas une identification certaine. E — Vrai. Ils sont présentés sans la même limitation saisonnière.

Q16 — Réponses : A, D, E. A — Vrai. Ils font partie des publics cités. B — Faux. Les publics concernés se distinguent par leur âge et leur terrain, sans exposition exclusive de ce type. C — Faux. Les astrovirus sont des agents distincts de Salmonella Typhi. D — Vrai. Les personnes immunodéprimées font partie des publics concernés. E — Vrai. Elles sont explicitement mentionnées.

Q17 — Réponses : E. A — Faux. La dispersion citée ne constitue pas cette preuve. B — Faux. Ils peuvent au contraire participer à une dispersion contaminante. C — Faux. Ce signe ne suffit pas à identifier l'agent. D — Faux. Ils peuvent s'ajouter aux pertes digestives. E — Vrai. Les vomissements peuvent disperser l'agent infectieux.

Pertes hydriques et réhydratation

Q18 — Réponses : B. A — Faux. Cette distinction concerne l'agent, pas le déficit hydrique. B — Vrai. Elles sont directement liées au retentissement digestif. C — Faux. C'est une démarche de caractérisation au laboratoire. D — Faux. Elle relève du diagnostic microbiologique. E — Faux. Elle relève de l'antibiogramme.

Q19 — Réponses : A. A — Vrai. L'absorption du sodium et du glucose est couplée. B — Faux. Ce ne sont pas les deux composants du mécanisme présenté. C — Faux. Cela concerne la physiopathologie typhoïdique, pas l'absorption sodium–glucose. D — Faux. Elle décrit la PCR multiplex. E — Faux. Ce mécanisme est lésionnel et distinct de la réhydratation.

Q20 — Réponses : E. A — Faux. Ils concernent la prise en charge et ne sont pas des techniques d'identification. B — Faux. Cette déduction confond évolution des selles et correction du déficit. C — Faux. La déshydratation est un enjeu important lors d'une gastro-entérite virale. D — Faux. L'analyse microbiologique ne mesure pas les apports hydriques. E — Vrai. Le bilan hydrique reste une question distincte.

Corrigés argumentés

Salmonelles et typhoïde

Q21 — Réponses : A, C. A — Vrai. Elles sont opposées au groupe typhique. B — Faux. Ce sont des virus distincts des salmonelles. C — Vrai. Typhi et Paratyphi sont associés aux fièvres typhoïdes et paratyphoïdes. D — Faux. Ce sont des groupes d'E. coli. E — Faux. Il appartient à un autre genre bactérien.

Q22 — Réponses : E. A — Faux. Ce n'est pas le réservoir décrit pour les salmonelles typhiques. B — Faux. Cela contredit le réservoir strictement humain des salmonelles typhiques. C — Faux. Le réservoir des salmonelles typhiques est strictement humain. D — Faux. Ce repère ne correspond pas aux salmonelles typhiques. E — Vrai. Ce réservoir diffère de celui des salmonelles non typhiques.

Q23 — Réponses : B. A — Faux. La bactérie franchit la barrière intestinale et se dissémine dans l'hôte. B — Vrai. Elle explique que le tableau ne reste pas limité aux selles. C — Faux. Des signes généraux peuvent dominer avec une constipation. D — Faux. Le franchissement fait partie du mécanisme présenté. E — Faux. Le tableau comporte des manifestations générales de dissémination.

Q24 — Réponses : E. A — Faux. Le mécanisme décrit concerne des cellules de l'hôte. B — Faux. Un macrophage est une cellule, pas un groupe bactérien. C — Faux. Leur rôle physiopathologique n'est pas une technique de sérotypage. D — Faux. Le prélèvement et la cellule ne doivent pas être confondus. E — Vrai. La bactérie peut survivre et se multiplier dans les macrophages.

Q25 — Réponses : A. A — Vrai. La typhoïde ne se résume pas à une diarrhée persistante. B — Faux. Un signe isolé ne démontre pas cet agent. C — Faux. La maladie est systémique et peut s'accompagner d'une constipation. D — Faux. Cette conclusion n'est pas compatible avec le tableau présenté. E — Faux. La constipation ne fournit pas cette caractérisation.

Q26 — Réponses : B. A — Faux. La dissociation décrite porte sur la relation pouls–fièvre. B — Vrai. C'est la relation expliquée à l'oral. C — Faux. Ce n'est pas le repère expliqué. D — Faux. La notion est discutée dans un tableau fébrile. E — Faux. La typhoïde décrite comporte au contraire des signes généraux.

Q27 — Réponses : B. A — Faux. Une coproculture étudie des selles, pas du sang. B — Vrai. Il correspond à la recherche de bactéries dans le compartiment sanguin. C — Faux. Il ne recherche pas une bactériémie chez le patient. D — Faux. Une mesure clinique n'est pas un échantillon de sang. E — Faux. Il renseigne une exposition et ne constitue pas un prélèvement biologique.

Corrigés argumentés

Q28 — Réponses : B, D. A — Faux. De nombreux animaux peuvent constituer un réservoir de salmonelles non typhiques. B — Vrai. Ces manifestations appartiennent au tableau présenté. C — Faux. La gastro-entérite est précisément le tableau décrit. D — Vrai. Des aliments contaminés peuvent transmettre les salmonelles non typhiques. E — Faux. Une gastro-entérite peut survenir après une exposition alimentaire.

Q29 — Réponses : A, B. A — Vrai. Elles font partie des aggravations décrites. B — Vrai. Des perforations intestinales peuvent aussi compliquer une typhoïde. C — Faux. C'est un résultat de caractérisation, pas une lésion. D — Faux. Les deux notions ne se confondent pas. E — Faux. Un portage et une complication anatomique sont distincts.

TIAC et prévention générale

Q30 — Réponses : C. A — Faux. Le dernier mot du sigle est collective, qui insiste sur le groupement de cas. B — Faux. Le développement enseigné mentionne une origine alimentaire et un caractère collectif. C — Vrai. Le sigle décrit le caractère alimentaire et groupé. D — Faux. Ce n'est pas le développement du sigle TIAC. E — Faux. Ce développement ne correspond pas à la toxi-infection collective.

Q31 — Réponses : E. A — Faux. L'exposition commune suspectée ne suffit pas à identifier l'agent. B — Faux. L'enquête vise précisément le point commun. C — Faux. L'eau peut intervenir dans la chaîne de contamination. D — Faux. La caractérisation biologique ne remplace pas l'enquête d'exposition. E — Vrai. L'exposition partagée oriente l'enquête.

Q32 — Réponses : B, C, D. A — Faux. Une analyse n'assure pas la conservation des aliments. B — Vrai. Elle limite un transfert vers les aliments. C — Vrai. Il appartient aux mesures alimentaires citées. D — Vrai. Une eau contaminée peut exposer directement ou indirectement. E — Faux. Cela favorise une contamination au lieu de la prévenir.

Q33 — Réponses : D. A — Faux. Éliminer des excrétas n'est pas analyser un échantillon. B — Faux. L'introduction de matières fécales peut contaminer le point d'eau. C — Faux. Le transfert peut atteindre l'environnement puis d'autres patients. D — Vrai. L'oral relie ce geste au risque pour les autres patients. E — Faux. Les excrétas doivent suivre le circuit prévu pour éviter de contaminer les points d'eau.

Corrigés argumentés

Shigella et syndrome dysentérique

Q34 — Réponses : D. A — Faux. L'invasion décrite concerne l'intestin. B — Faux. L'invasion entraîne des lésions de la barrière intestinale. C — Faux. Cela ne décrit pas le mécanisme invasif présenté. D — Vrai. Elle participe au syndrome dysentérique décrit. E — Faux. L'inflammation est une composante importante du modèle.

Q35 — Réponses : B. A — Faux. Le terme mentionne précisément les deux composantes. B — Vrai. Les deux composantes expliquent le terme. C — Faux. Cela ne couvre qu'une composante du terme. D — Faux. Cela ne couvre qu'une composante du terme. E — Faux. C'est un aspect clinique des selles, pas une description de colonies.

Q36 — Réponses : C, D. A — Faux. Le tableau présenté comporte des douleurs. B — Faux. Le syndrome est relié à des mécanismes inflammatoires et lésionnels. C — Vrai. Elles font partie du tableau décrit. D — Vrai. Les épreintes et le ténesme sont cités. E — Faux. L'examen biologique et les manifestations cliniques sont distincts.

Q37 — Réponses : D. A — Faux. Ce sont des cellules de la réponse inflammatoire. B — Faux. Le rôle décrit concerne la réaction de l'hôte dans les lésions. C — Faux. Elle ne réalise pas un sérotypage ni une identification d'espèce. D — Vrai. Les polynucléaires neutrophiles sont recrutés vers les tissus atteints. E — Faux. L'étude de sensibilité relève de l'antibiogramme.

Q38 — Réponses : B, E. A — Faux. La contamination passe par une voie digestive. B — Vrai. Elle peut véhiculer l'agent digestif. C — Faux. La voie présentée repose sur l'ingestion d'eau ou d'aliments souillés. D — Faux. Le test n'est pas une condition de la contamination. E — Vrai. La contamination alimentaire est également citée.

Yersinioses digestives

Q39 — Réponses : B, C. A — Faux. Elle est citée dans l'historique, pas comme l'espèce digestive à retenir ici. B — Vrai. Elle est également abordée. C — Vrai. Elle appartient aux espèces digestives citées. D — Faux. Elle appartient à un autre genre. E — Faux. C'est un virus et non une espèce de Yersinia.

Corrigés argumentés

Q40 — Réponses : C. A — Faux. C'est un autre groupe bactérien et un autre tableau. B — Faux. La yersiniose ne se confond pas avec cette infection. C — Vrai. La forme entéritique est un tableau important chez le petit enfant. D — Faux. Une entérite est une forme clinique digestive, pas ce portage. E — Faux. L'entérite prioritaire est précisément une forme digestive.

Q41 — Réponses : D. A — Faux. Le mécanisme cité associe ganglions et iléon terminal. B — Faux. La localisation ne fournit pas cette identification. C — Faux. L'adénite désigne au contraire une atteinte inflammatoire ganglionnaire. D — Vrai. L'adénite et l'inflammation de l'iléon terminal peuvent expliquer ce tableau. E — Faux. Le mécanisme anatomique présenté est une adénite avec iléite.

Escherichia coli : flore et invasion

Q42 — Réponses : B, E. A — Faux. Les Escherichia coli regroupent plusieurs profils pathogènes, dont des groupes digestifs. B — Vrai. Sa présence ne définit pas à elle seule le même tableau pathologique. C — Faux. Il est présenté comme une bactérie. D — Faux. Il faut distinguer flore habituelle et facteurs de virulence. E — Vrai. Ils expliquent des tableaux différents.

Q43 — Réponses : A. A — Vrai. L'invasion explique le rapprochement avec Shigella. B — Faux. Ce repère correspond à UPEC, pas EIEC. C — Faux. Le groupe est qualifié d'entéro-invasif. D — Faux. EIEC et Salmonella Typhi sont distincts. E — Faux. EIEC désigne des E. coli bactériens.

Q44 — Réponses : A. A — Vrai. Il est relié à l'invasion intestinale. B — Faux. Cette proposition confond EIEC et UPEC. C — Faux. Le groupe est entéro-invasif. D — Faux. Il s'agit d'un autre agent. E — Faux. Une présence sans symptômes ne définit pas ce syndrome.

Q45 — Réponses : A. A — Vrai. Les Escherichia coli uropathogènes sont associés aux infections urinaires. B — Faux. UPEC désigne un groupe d'E. coli. C — Faux. Ce repère correspond à EIEC. D — Faux. Il s'agit d'E. coli bactériens. E — Faux. Les termes ne désignent pas le même agent.

Corrigés argumentés

Campylobacter et alimentation

Q46 — Réponses : A. A — Vrai. La volaille est un repère de contamination alimentaire par Campylobacter. B — Faux. Ce n'est pas le réservoir animal associé à Campylobacter dans cette question. C — Faux. Le réservoir animal est explicitement développé. D — Faux. Les animaux et leur tube digestif constituent un réservoir de Campylobacter. E — Faux. L'eau peut transmettre, mais n'efface pas le réservoir animal.

Q47 — Réponses : E. A — Faux. La contamination de la carcasse précède sa consommation. B — Faux. Ce n'est pas une condition du mécanisme à l'abattoir. C — Faux. La cuisson insuffisante ne crée pas le réservoir ; elle peut laisser persister le risque. D — Faux. Le mécanisme de contamination ne dépend pas de cet examen. E — Vrai. L'oral décrit ce risque lors de l'abattage.

Q48 — Réponses : B, D, E. A — Faux. Ce n'est pas une exposition alimentaire ou hydrique citée. B — Vrai. Elle est une autre voie digestive présentée. C — Faux. Cette infection distincte n'est pas une condition de contamination par Campylobacter. D — Vrai. Elle peut véhiculer l'agent provenant du réservoir animal. E — Vrai. Du lait non pasteurisé contaminé peut transmettre Campylobacter.

Q49 — Réponses : E. A — Faux. Il s'agit de l'inoculum. B — Faux. Il s'agit de l'incubation. C — Faux. La coproculture est une analyse. D — Faux. Cela correspond à l'antibiogramme. E — Vrai. C'est la définition expliquée à l'oral.

Q50 — Réponses : D. A — Faux. Un contexte saisonnier ne remplace pas l'identification biologique. B — Faux. La préparation alimentaire est distincte d'une méthode de culture. C — Faux. Cette conclusion n'est pas établie par le contexte. D — Vrai. Le lien porte sur la cuisson et l'agent d'origine animale. E — Faux. La cuisson insuffisante est le lien central de l'exemple.

Q51 — Réponses : B, C. A — Faux. C'est une caractérisation de souche, pas un signe chez le patient. B — Vrai. Elle appartient à la présentation digestive. C — Vrai. Ils sont également cités. D — Faux. Il s'agit d'une entérite, qui atteint l'intestin. E — Faux. La sensibilité de la souche et un signe clinique sont distincts.

Corrigés argumentés

Nomenclature et portage

Q52 — Réponses : C. A — Faux. L'un est une bactérie, l'autre un virus. B — Faux. Ils appartiennent à des genres distincts. C — Vrai. Clostridium difficile est l'ancien nom de Clostridioides difficile. D — Faux. Ce sont deux agents distincts. E — Faux. UPEC désigne un groupe d'E. coli.

Q53 — Réponses : E. A — Faux. Le portage ne définit pas un résultat de sensibilité. B — Faux. Cela contredit le caractère asymptomatique. C — Faux. Une complication anatomique n'est pas la notion de portage. D — Faux. Le portage suppose au contraire une présence. E — Vrai. La notion est distinguée de l'infection clinique.

Prélèvements et laboratoire

Q54 — Réponses : D. A — Faux. Il ne constitue pas le prélèvement digestif central présenté. B — Faux. Il renseigne le contexte sans être l'échantillon microbiologique. C — Faux. Elle n'est pas un prélèvement de matière biologique. D — Vrai. Elles permettent d'explorer les agents du trouble digestif. E — Faux. Il ne remplace pas le prélèvement de l'épisode étudié.

Q55 — Réponses : C. A — Faux. Il s'agit d'une hémoculture. B — Faux. C'est une observation clinique, pas une culture. C — Vrai. Le terme décrit le prélèvement étudié et la méthode. D — Faux. Elle correspond au sérotypage. E — Faux. Elle décrit plutôt une PCR multiplex.

Q56 — Réponses : C. A — Faux. La flore digestive contient une grande diversité de micro-organismes. B — Faux. L'identification nécessite une démarche biologique. C — Vrai. Le germe recherché doit être distingué parmi de nombreuses bactéries. D — Faux. Le laboratoire cherche un agent spécifique. E — Faux. Des méthodes sélectives servent précisément à cette recherche.

Q57 — Réponses : E. A — Faux. Cette fréquence est une donnée clinique. B — Faux. La PCR recherche une cible génétique. C — Faux. La culture et la PCR sont des méthodes distinctes. D — Faux. Elle ne se confond pas avec l'antibiogramme présenté. E — Vrai. C'est le principe de la recherche moléculaire décrite.

Corrigés argumentés

Q58 — Réponses : B. A — Faux. Le terme concerne le nombre de cibles, pas un délai imposé. B — Vrai. Un panel de PCR multiplex recherche plusieurs cibles dans une même analyse. C — Faux. Plusieurs cibles recherchées ne signifient pas plusieurs agents présents. D — Faux. Ce n'est pas la définition de multiplex. E — Faux. Le multiplex décrit ici une recherche moléculaire de cibles.

Q59 — Réponses : D. A — Faux. Un milieu de culture est utilisé au laboratoire. B — Faux. Cette information relève de l'observation clinique. C — Faux. L'identification est une étape distincte. D — Vrai. Le milieu est choisi pour la recherche biologique. E — Faux. Le milieu vise la recherche d'agents, pas le bilan des pertes.

Q60 — Réponses : D. A — Faux. C'est une prise en charge et non une méthode d'identification. B — Faux. Elle recherche l'exposition collective. C — Faux. C'est une donnée clinique. D — Vrai. Il intervient après l'obtention de matériel bactérien en culture. E — Faux. La fonction présentée est l'identification de colonies au laboratoire.

Q61 — Réponses : B. A — Faux. La caractérisation antigénique ne mesure pas la déshydratation. B — Vrai. Cette distinction est importante pour relier agent et tableau clinique. C — Faux. Le sérotypage caractérise, il ne transforme pas la souche. D — Faux. Le suivi clinique ne se confond pas avec le sérotypage. E — Faux. Cette fonction relève de l'antibiogramme.

Q62 — Réponses : D. A — Faux. Le test de sensibilité ne pose pas à lui seul une indication thérapeutique. B — Faux. Ce n'est pas une mesure des pertes. C — Faux. Cette information relève de l'enquête d'exposition. D — Vrai. Elle concerne la souche isolée et les molécules testées. E — Faux. Ce n'est pas ce que mesure cet examen.

Q63 — Réponses : C. A — Faux. La détection et la sensibilité sont des informations distinctes. B — Faux. L'observation ne remplace pas les examens microbiologiques. C — Vrai. Identifier une cible et connaître une sensibilité ne sont pas la même opération. D — Faux. Elle caractérise la souche, pas le retentissement hydrique. E — Faux. Les deux méthodes reposent sur des démarches différentes.